

TEMA 7.6 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos del Ánimo: Depresión Mayor

PERFIL EUNACOM 4.01.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los **trastornos del ánimo** constituyen uno de los pilares fundamentales de la salud mental, siendo la depresión una de las patologías más frecuentes en la consulta médica en Chile. Estos trastornos abarcan un espectro que va desde la depresión unipolar hasta el **Trastorno Bipolar**, pasando por cuadros crónicos como la distimia.

Conceptos Fundamentales y Diagnóstico

El diagnóstico de todas las patologías psiquiátricas, incluyendo la depresión, es estrictamente **clínico**. No existen biomarcadores ni pruebas de imagen que confirmen el diagnóstico, aunque los exámenes de laboratorio son esenciales para el diagnóstico diferencial.

Criterios de Depresión Mayor

Para hablar de un episodio de **Depresión Mayor**, los síntomas deben cumplir con dos condiciones básicas de temporalidad y calidad: 1. **Duración:** Mínimo **14 días** (2 semanas) de síntomas continuos. 2. **Síntomas Cardinales:** Debe estar presente el ánimo deprimido (tristeza patológica) y/o la **anhedonia**.

NOTA CLÍNICA

La **anhedonia** es la incapacidad de experimentar placer en actividades que habitualmente resultaban gratificantes para el paciente (hobbies, comida, vida social, etc.). Es un marcador biológico clave de la depresión.

Otros Síntomas Asociados

Alteraciones del peso: Habitualmente baja de peso, aunque puede aumentar en variantes específicas. **Alteraciones del sueño:** Lo más frecuente es el **insomnio de conciliación o terminal**, pero también puede presentarse como hipersomnía. **Disfunción cognitiva:** Problemas de concentración y memoria. **Alteraciones de la libido:** Disminución del deseo sexual. **Ideación:** Es vital distinguir entre: **Ideas de muerte:** Pensar que la muerte es una solución o un descanso. **Ideación suicida:** La intención o plan de quitarse la vida activamente. **Desesperanza:** Sentimiento de que el futuro no ofrece mejoría.

Estudio Inicial y Descarte Orgánico

Antes de confirmar un trastorno primario del ánimo, es obligatorio descartar causas médicas que simulen una depresión.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca inicie tratamiento antidepresivo sin antes solicitar niveles de **TSH**. El **Hipotiroidismo** es el gran simulador de la depresión y su tratamiento es la reposición hormonal, no el antidepresivo.

- El screening mínimo recomendado por la guía ministerial incluye:
- **TSH (y T4 libre):** Para descartar patología tiroidea.
- **Hemograma:** Para descartar anemia (que causa fatiga y astenia).
- **Glicemia:** Para descartar diabetes mellitus.

Clasificación y Tipos de Depresión

La depresión no es una entidad única; se manifiesta en distintos subtipos clínicos que orientan el tratamiento:

TABLA 7.6.1: TIPO DE DEPRESIÓN VS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PRINCIPALES

TIPO DE DEPRESIÓN	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PRINCIPALES	PERLA TERAPÉUTICA
Melancólica	Tristeza profunda, anhedonia severa, insomnio de despertar precoz, baja de peso marcada.	Respuesta clásica a ISRS .
Atípica	Hipersomnía, aumento de peso , "craving" por dulces, sensibilidad extrema al rechazo.	Clásicamente se asocia a respuesta con IMAO (Fenelzina).
Psicótica	Síntomas depresivos + pérdida del juicio de realidad (delirios).	ISRS + Antipsicótico atípico.
Reactiva	Secundaria a un gatillante vital claro (duelo, despido, quiebre amoroso).	Psicoterapia + fármacos según severidad.
Recurrente	Más de un episodio en la vida. Los episodios posteriores suelen ser espontáneos (sin gatillante).	Mantener fármacos a permanencia o largo plazo.
Doble	Un episodio de Depresión Mayor que se superpone a una Distimia (depresión leve crónica).	Manejo complejo.

Depresión Psicótica: Los Delirios Clásicos

En la depresión psicótica, los delirios suelen ser "congruentes con el ánimo". Los tres más característicos son: 1. **Delirio de Ruina:** Convicción de estar en la miseria económica o social absoluta, sin salida. 2. **Delirio de Culpa:** Sentimiento de responsabilidad delirante sobre eventos negativos (ej. creer que un familiar murió de cáncer por culpa del paciente). 3. **Delirio de Enfermedad (Somático):** Convicción de padecer una enfermedad terminal o catastrófica a pesar de exámenes normales.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si el paciente presenta delirios paranoides o extraños, se debe sospechar un **Trastorno Esquizoafectivo** o **Esquizofrenia**, más que una depresión psicótica pura.

Diagnóstico Diferencial: Depresión Reactiva vs. Trastorno Adaptativo

Es fundamental distinguir si una reacción ante un estrés vital es una depresión o un **Trastorno Adaptativo**, ya que esto cambia la conducta terapéutica.

Intensidad: La depresión reactiva es mucho más invalidante; el paciente "no puede" con su vida. El trastorno adaptativo es un malestar significativo pero de menor calado. **Síntomas Biológicos:** La presencia de cambios marcados en el peso y el sueño sugieren fuertemente una Depresión. **Ideación Suicida:** Su presencia inclina la balanza hacia el diagnóstico de Depresión.

NOTA CLÍNICA

En el **Trastorno Adaptativo**, el tratamiento suele ser psicoterapéutico y manejo ambiental. En la **Depresión Reactiva**, la intensidad de los síntomas suele requerir el uso de fármacos.

Principios Generales del Tratamiento

El manejo de la depresión mayor es dual:

- **Psicoterapia:** Enfocada en el manejo del estrés, resolución de conflictos, autoconocimiento y herramientas de afrontamiento.
- **Farmacoterapia:**

- **ISRS (Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina):** Son la primera línea (Fluoxetina, Sertralina, Citalopram, Paroxetina).
- **IMAO:** Reservados para casos muy específicos como la depresión atípica (poco usados hoy por sus interacciones).
- **Antipsicóticos:** Solo como coadyuvantes en casos de síntomas psicóticos o depresiones refractarias.

EUNACOM CRITERIOS

En la **Depresión Recurrente**, el riesgo de recaída al suspender el fármaco es muy alto. Se debe explicar al paciente que el tratamiento probablemente será de por vida o por periodos de años para evitar nuevos episodios.

Trastornos del Ánimo: Farmacoterapia Urgencias Psiquiátricas: Riesgo Suicida

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 42 años consulta por tristeza intensa y llanto frecuente desde hace 3 semanas, desde que su empresa la despidió. Ha bajado 5 kg de peso, duerme muy poco y refiere que "nunca más encontrará trabajo y nada tiene solución". Tiene TSH, hemograma y glicemia normales. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos del Ánimo: Depresión Mayor. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La depresión mayor requiere mínimo 14 días de síntomas; los cardinales son tristeza persistente y/o anhedonia.
- Los exámenes en depresión descartan causas orgánicas: TSH (hipotiroidismo, el más importante), hemograma (anemia) y glicemia (diabetes).
- La depresión atípica: hipersomnia, aumento de peso, craving por dulces; tratamiento de elección son los IMAOs (fenelzina).
- La depresión psicótica: delirio de ruina, culpa o enfermedad; requiere ISRS + antipsicótico atípico.
- Diferencia depresión reactiva vs trastorno adaptativo: la primera tiene tristeza intensa, cambios en peso/sueño e ideas de muerte; la segunda es más leve y con esperanza preservada.
- Las depresiones recurrentes (segundo o tercer episodio) requieren antidepresivos a largo plazo o indefinidamente.
- La desesperanza en depresión puede alcanzar el nivel de delirio de ruina, marcando una depresión psicótica.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DEL ÁNIMO: DEPRESIÓN MAYOR)**PREGUNTA 1**

Mujer de 42 años consulta por tristeza intensa y llanto frecuente desde hace 3 semanas, desde que su empresa la despidió. Ha bajado 5 kg de peso, duerme muy poco y refiere que "nunca más encontrará trabajo y nada tiene solución". Tiene TSH, hemograma y glicemia normales. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

- A)** Trastorno adaptativo; solo psicoterapia
- B)** Duelo normal; no requiere tratamiento
- C)** Depresión reactiva; psicoterapia más antidepresivo ISRS
- D)** Depresión psicótica; ISRS más antipsicótico
- E)** Hipotiroidismo; levotiroxina

PREGUNTA 2

Hombre de 55 años con depresión en tratamiento con sertralina 50 mg/día por 8 semanas refiere estar "igual de deprimido que al inicio" y además presenta disminución del deseo sexual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Mantener la sertralina y esperar más tiempo
- B)** Agregar un segundo antidepresivo ISRS
- C)** Cambiar a antidepresivo dual (venlafaxina o duloxetina) por falla al ISRS
- D)** Cambiar a mirtazapina, que no produce alteraciones sexuales y tiene efecto antidepresivo dual
- E)** Agregar sildenafil para la disfunción sexual y mantener sertralina

PREGUNTA 3

Paciente de 65 años presenta tristeza severa de 6 semanas, no come, no duerme y desde hace 2 días refiere con total certeza que "está arruinado económicamente y que sus deudas no tienen solución", aunque sus hijos confirman que su situación financiera es estable. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

- A)** Depresión mayor sin psicosis; ISRS solo
- B)** Trastorno delirante crónico; antipsicótico solo
- C)** Depresión psicótica; ISRS más antipsicótico atípico
- D)** Esquizofrenia de inicio tardío; antipsicótico solo
- E)** Demencia con síntomas psicóticos; antipsicótico

RESUMEN: TRASTORNOS DEL ÁNIMO: DEPRESIÓN MAYOR

La depresión mayor (o simplemente depresión) requiere al menos 14 días de síntomas, siendo los síntomas cardinales la tristeza persistente y/o la anhedonia (pérdida de la capacidad de experimentar placer). Se acompaña frecuentemente de cambios en el peso y apetito (generalmente baja, aunque en la depresión atípica hay aumento), alteraciones del sueño (principalmente insomnio), dificultades de concentración, alteraciones en la vida sexual, ideas de muerte e ideación suicida. La desesperanza es un síntoma de gravedad que puede llegar al delirio de ruina en las formas más severas. El diagnóstico es clínico. Los exámenes solicitados buscan descartar causa orgánica: TSH (lo más importante, para descartar hipotiroidismo), hemograma (anemia) y glicemia (diabetes). El tratamiento combina psicoterapia (cognitivo-conductual) y antidepresivos (ISRS de primera línea). Existen varios subtipos clínicamente relevantes. La depresión melancólica es la forma clásica con tristeza, anhedonia, baja de peso e insomnio, tratada con ISRS. La depresión atípica se distingue por hipersomnia, aumento de peso, craving por dulces e intolerancia al rechazo; el tratamiento de elección son los IMAOs (fenelzina). La depresión psicótica se complica con delirio, generalmente de ruina, culpa o enfermedad; requiere ISRS más antipsicótico atípico. La depresión reactiva tiene un gatillante claro (pérdida, crisis vital) y en el primer episodio es lo más frecuente. La diferencia entre depresión reactiva y trastorno adaptativo es clínicamente relevante porque determina el tratamiento. La depresión reactiva es más intensa: tristeza muy marcada, ideación de muerte, cambios en peso/sueño; requiere antidepresivos. El trastorno adaptativo es menos intenso, sin cambios en peso/sueño, con esperanza preservada; se maneja solo con psicoterapia. Las depresiones recurrentes (segundo o tercer episodio) suelen aparecer sin gatillante claro y requieren antidepresivos a largo plazo o indefinidamente para prevenir recaídas.